HIV/AIDS NGHỀ NGHIỆP

Yếu tố căn nguyên

- Nhiễm HIV.
- Đường lan truyền:
- Tiêm truyền: dùng chung bơm kim tiêm
- Qua mẹ truyền cho con
- Tiếp xúc với đồ dùng, dụng cụ dính máu bệnh nhân
- Bệnh phẩm bệnh nhân

Diễn biến tự nhiên và các biểu hiện của nhiễm HIV/AIDS

- 1. ***Giai đoạn sơ nhiễm***
- Chỉ có 20 - 50% có biểu hiện lâm sàng với các triệu chứng giống như bệnh cảnh nhiễm các vi rút khác, với các biểu hiện:
- 1.1. Lâm sàng
- Hội chứng giả bệnh tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng hoặc giả cúm.
- Sốt 38 - 40^0C, hoặc sốt nhẹ thất thường.
- Đau đầu, mệt mỏi, đau nhức mình mẩy toàn thân.

- Sưng hạch ở một số nơi như cổ, nách.
- Phát ban dạng sởi hoặc sẩn ngứa trên da.
- Một số trường hợp có biểu hiện của viêm màng não nước trong
- Nôn, buồn nôn, tiêu chảy.
- Ở giai đoạn này, triệu chứng sẽ tự hết sau vài ngày hoặc vài tuần, bệnh nhân vẫn thấy người bình thường;
- 1.2. Xét nghiệm
- Bạch cầu đơn nhân tăng.
- Enzym AST (SGOT), ALT (SGPT) tăng vừa.
- Chọc tủy sống có thấy biểu hiện của viêm màng não nước trong
- Những thay đổi trên sẽ hết sau 7 - 10 ngày.

- Các xét nghiệm kháng nguyên xét nghiệm HIV (nếu có điều kiện).
- Xét nghiệm nồng độ vi rút trong máu (nếu có điều kiện).

2. Giai đoạn nhiễm không có triệu chứng

- Bệnh nhân không có biểu hiện gì trên lâm sàng nhưng trong máu có HIV và trở thành nguồn lây cho mọi người qua hành vi nguy cơ của họ.
- Giai đoạn này kéo dài từ 5 đến 20 năm, hoặc lâu hơn.
- Thường có 3 xu hướng phát triển:
- Hoặc trở thành người mang HIV kéo dài trong nhiều năm nhưng vẫn khỏe mạnh nếu người nhiễm quyết tâm thay đổi hành vi, luyện tập thể chất, chế độ sinh hoạt hợp lý và được thường xuyên theo dõi về sức khỏe.

- Hoặc HIV diễn biến tự nhiên trong cơ thể, tiêu hủy dần các tế bào miễn dịch, diễn biến dai dẳng rồi trở thành bệnh nhân AIDS trong vòng 5 đến 7 năm.
- Hoặc nhiễm HIV diễn biến nhanh thành AIDS trong vòng 1 đến 2 năm nếu người bệnh tiếp tục hành vi nguy cơ của họ.
- Hoặc bệnh nhân có duy nhất biểu hiện bệnh lý hạch toàn thân dai dẳng: thường sưng hạch vùng cổ, nách, hạch to 1 - 2cm, không đau, di động dễ, sinh thiết hạch thấy hiện tượng tăng sinh.

3. ***Giai đoạn có triệu chứng***

- Sụt cân
- Sốt kéo dài trên 38^0C mà không có nguyên nhân.
- Biểu hiện da, niêm mạc:

- Sẩn ngứa,
- viêm da tuyến bã,
- zona,
- viêm miệng hoặc loét miệng tái diễn,
- nấm miệng,
- bạch sản dạng lông ở miệng,
- ngứa dai dẳng, g
- ãi đến bật máu,
- dùng thuốc chống ngứa mà không khỏi.
- Một số có biểu hiện ho dai dẳng kéo dài hoặc tiêu chảy kéo dài mà không rõ nguyên nhân.
- Tiêu chảy.
- Biểu hiện hô hấp: nhiễm trùng hô hấp tái diễn, lao phổi

4. ***Giai đoạn AIDS***

- Với biểu hiện nhiễm trùng cơ hội và các khối u:
- Hội chứng suy mòn: sút cân trên 10% trọng lượng cơ thể, sốt kéo dài trên 1 tháng, tiêu chảy kéo dài trên 1 tháng.
- Viêm phổi

Chẩn đoán

1. Chẩn đoán xác định nhiễm HIV

1.1. Yếu tố tiếp xúc

- Dịch sinh học, máu người nhiễm HIV dây dính lên da, niêm mạc bị tổn thương.
- Có Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV
- Thời gian tiếp xúc: từ một lần trở lên.
- Thời gian chẩn đoán muộn nhất: 6 tháng sau lần tiếp xúc với dịch sinh học, máu người nhiễm HIV lên da, niêm mạc bị tổn thương.
- Mẫu huyết thanh của người đó dương tính cả ba lần xét nghiệm bằng ba loại sinh phẩm

1.2. Lâm sàng

- Có hoặc chưa có các biểu hiện hội chứng suy giảm miễn dịch và nhiễm trùng cơ hội (lao, viêm phổi, sốt kéo dài, rối loạn tiêu hoá...).

1.3. Cận lâm sàng

- Có kết quả xét nghiệm HIV theo quy định hiện hành của Bộ Y tế
- Kết quả xét nghiệm HIV ngay sau khi bị tai nạn rủi ro nghề nghiệp: âm tính (-).
- Kết quả xét nghiệm HIV của người bị phơi nhiễm với HIV tại một trong các thời điểm 01 tháng hoặc 03 tháng, 06 tháng

2. Chẩn đoán phân biệt

- Người nhiễm HIV có thời gian nhiều năm khoẻ mạnh như người bình thường

Các bước đánh giá và xử trí sau phơi nhiễm (7 bước)

- Xử lý vết thương tại chỗ.
- Báo cáo người phụ trách và làm biên bản (chú ý các thông tin trong hồ sơ phơi nhiễm).
- Đánh giá tình trạng HIV của nguồn gây phơi nhiễm.
- Xác định tình trạng HIV của người bị phơi nhiễm.
- Tư vấn cho người bị phơi nhiễm.
- Điều trị dự phòng bằng thuốc ARV.